

Pathologie des glandes salivaires

PLAN

- I. Glandes salivaires
- II. Sialites
- III. Sialoses
- IV. Tumeurs des glandes salivaires principales

I. Glandes salivaires

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DES GLANDES SALIVAIRES

INTRODUCTION

- Les glandes salivaires secrètent la salive, fluide essentiel dans les mécanismes physiologiques de:
 - La phonation
 - La mastication
 - La déglutition
 - La gustation

ANATOMIE DES GLANDES SALIVAIRES

- Glandes salivaires principales

- Parotide
- Sous-maxillaire
- Sublinguale



3 glandes paires

- Glandes salivaires accessoires

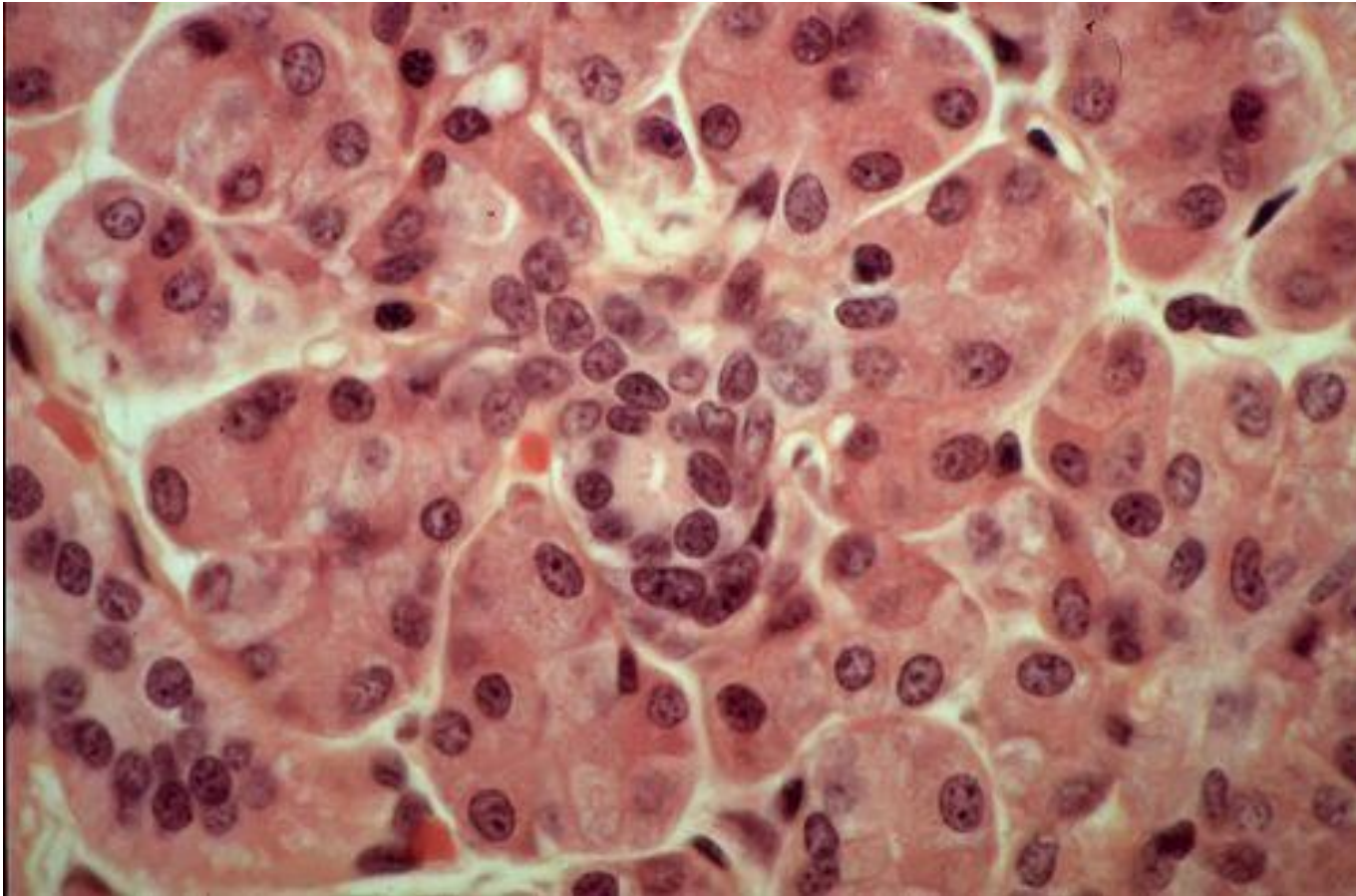
environ 1000 disséminées dans la cavité buccale

Morphologie

- Une capsule fibreuse
- Des cloisons conjonctives inter-lobulaires : canaux excréteurs inter-lobulaires , des vaisseaux , des nerfs
- Des lobules: le parenchyme: il s'agit de glandes tubuloacineuses; ramifiées faits d'acini et de canaux excreto-secreteurs:
- unité sécrétoire

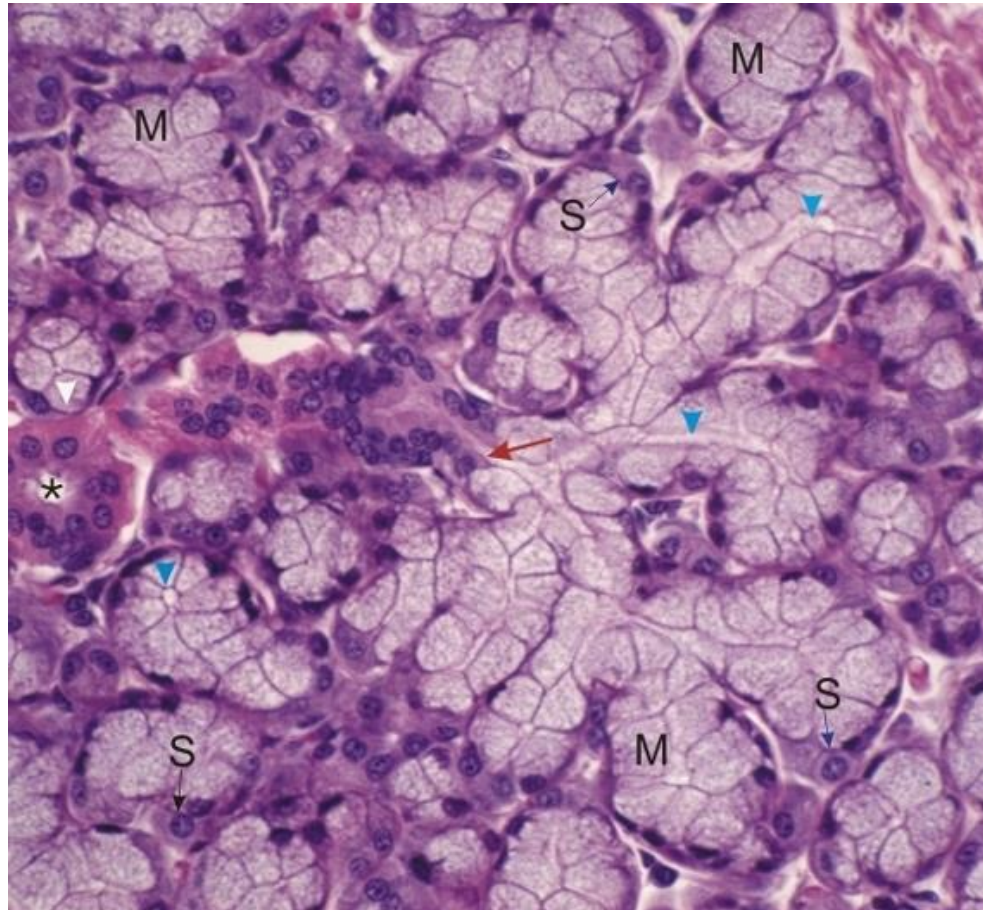
Parotide

- Acini séreux : petite taille, sphérique



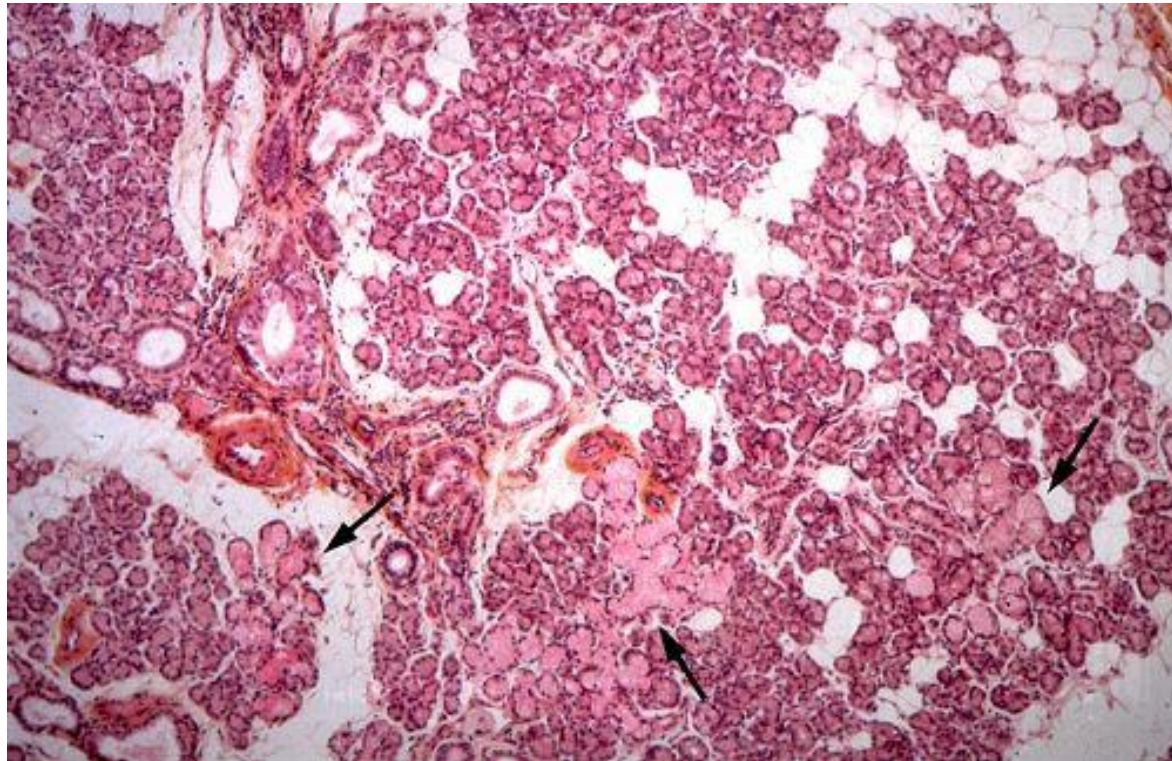
Sublinguale

- Acini muqueux allongé, lumière + grande



Sous maxillaire

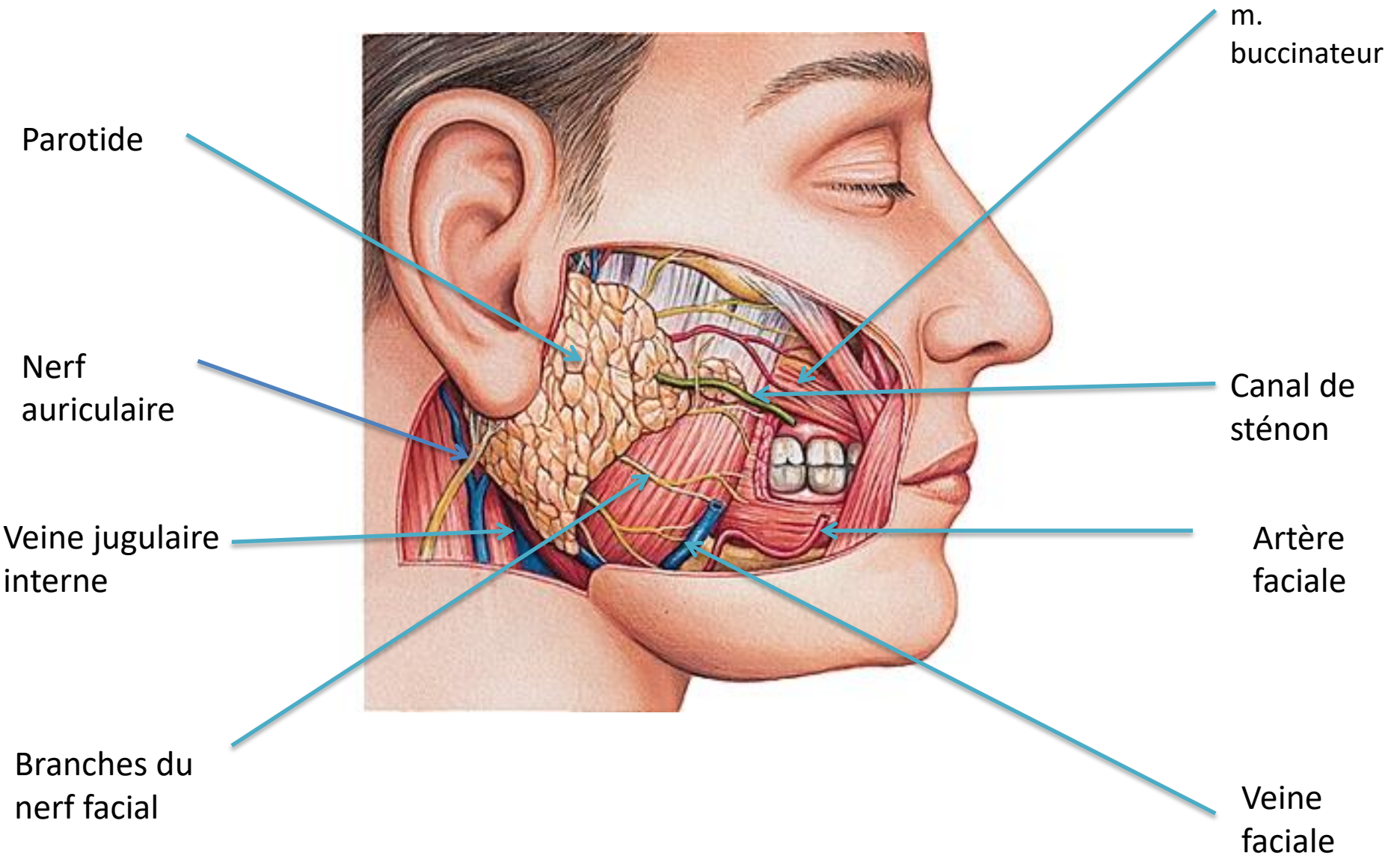
- Acini séreux, muqueux et séromuqueux
couronne acini muqueux + croissant de
cellules séreuses



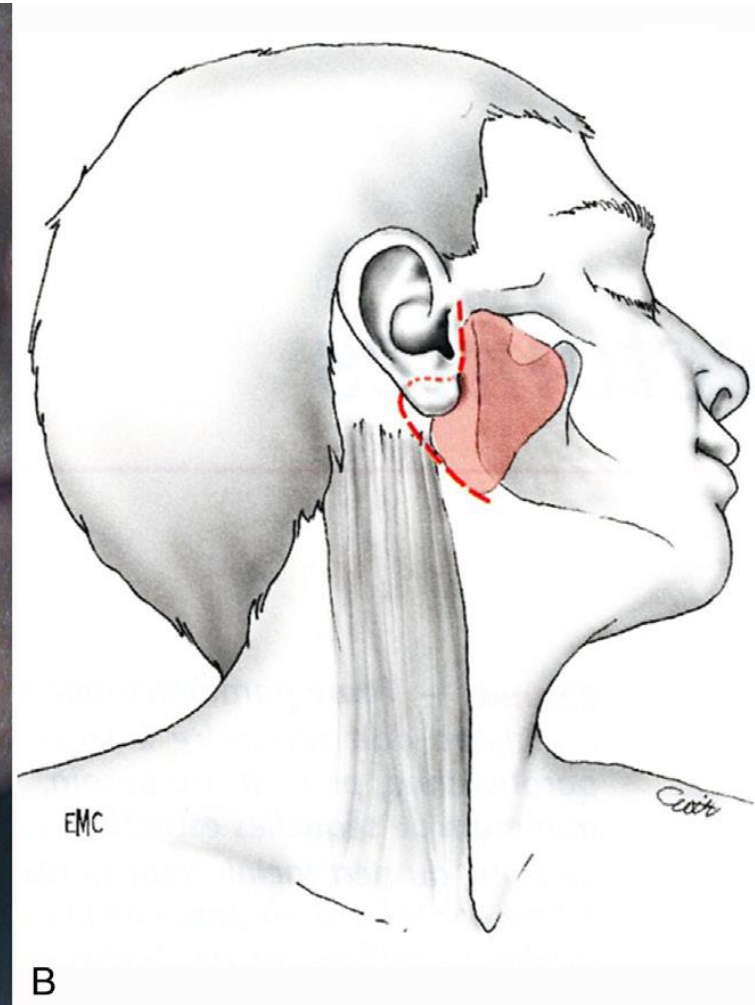
La glande parotide

- La plus volumineuse
- Situation anatomique superficielle au dessous et en avant du méat acoustique externe et en arrière du ramus mandibulaire.
- Les pathologies de la parotide sont dominées par les tumeurs: **Adénome pléiomorphe +++**

La glande parotide



Adénome pléiomorphe



PHYSIOLOGIE

- **Parotide:** sécrétion salivaire lors des repas
- **Sous maxillaire:** sécrétion de repose
- **Accessoires:** fonction de lubrification
- Anticorps, amylase, lysozyme
- 1,5L /j

II.Sialites

Sialites

- Inflammation des glandes salivaires
- Si point de départ parenchymateux:
sialadénite
- Lorsque l'inflammation est canalaire ou
secondaire à une atteinte canalaire:
sialadochite

Sialites virales

- La glande salivaire principale la plus fréquemment atteinte par les virus est **la parotide**.
- Paramyxovirus (Oreillons)++
- Grippe, influenzae A, coxsackie A, CMV, EBV...
- Otalgie, tuméfaction, fièvre, érythème Sténon, adénite
- Diagnostic clinique
- Repos, éviction scolaire (15 jours), antalgique, antipyrétique
- Complications (orchite avec stérilité, méningite, surdité d'où vaccin ROR)

Oreillons

- Paramyxovirus +++
- Tuméfaction parotidienne uni ou bilatérale, refoule le lobule de l'oreille associée à une otalgie fébrile.
- Érythème de l'ostium du canal de Sténon – signe de Koplick



Sialites microbiennes

- Touche indifféremment les glandes sous maxillaires ou parotides.
- Grave chez sujet âgé , états cachexiques, déshydratation, immunodépression spontanée ou induite.
- Staph , strepto , favorisée par une cause locale: caries, ATM.
- Clinique: douleur, signes inflammatoires locaux, fièvre, pus au sténon
- EPC: iono, prélèvement, +/- echo ou TDM si abcès/cellulite
- Traitement: Antibiothérapie (Spiramycine- Métronidazole), corticoides, rehydratation et antalgiques .
- Hospitalisation et traitement IV si besoin

Sialites microbiennes



Sialites tuberculeuses

- Touche 2 à 3 fois plus souvent la parotide.
- Nodule prétragien, fistulisé à la peau
- Atteinte ferme de la parotide qui est ferme et tendue.
- IDR+++
- DG-> Ponction biopsie: follicule tuberculeux et nécrose caséreuse
- TTT anti-tuberculeux après bilan dissémination

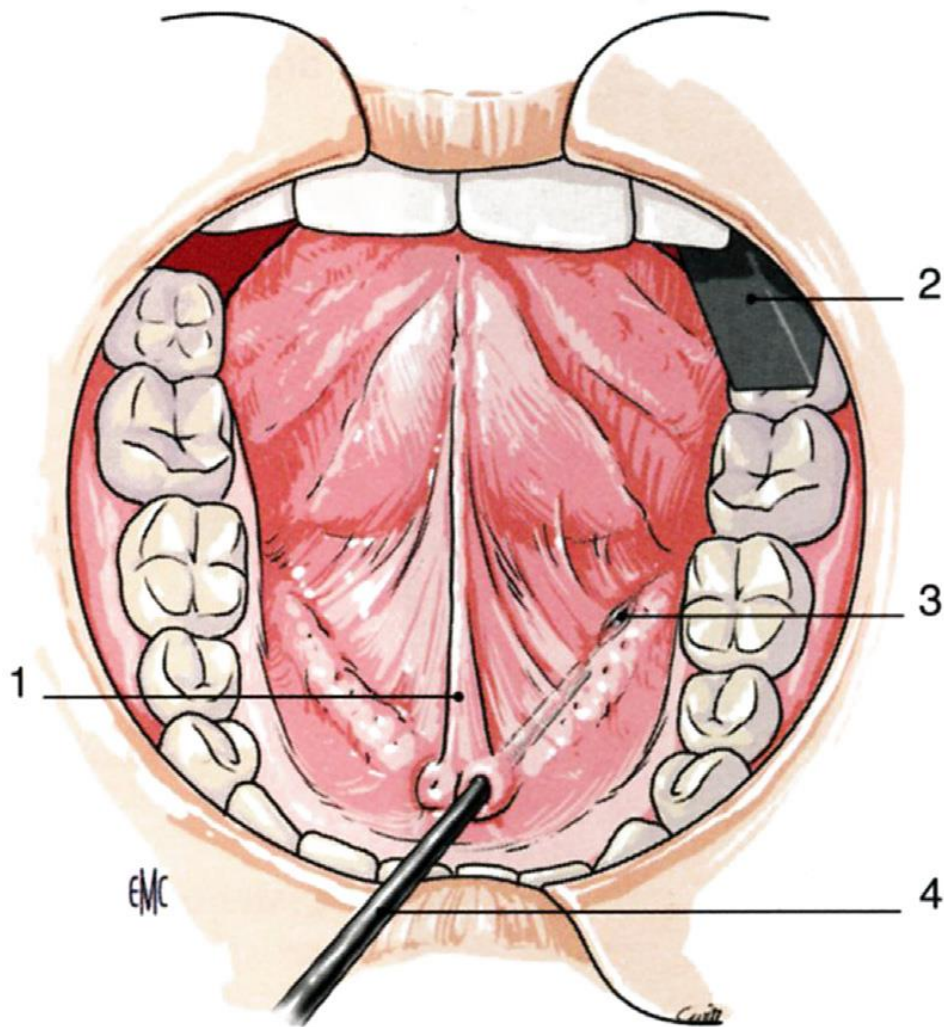
Sialites lithiasiques

- Touche 3 fois plus souvent la glande sous-maxillaire que la parotide.
- Colique slivaire (au moment du repas)
- Symptomatologie rythmée par les repas
- Augmentation du volume de la glande régressif en quelques jours

Sialites lithiasiques

- E. clinique:
 - palper endobuccal bimanuel
 - Radiographie maxillaire défilée
 - Echographie +++
 - Si suspicion d'abcès: TDM, IRM
- TTT moderne Sialendoscopie:
 - exérèse lithiase endoscopique/lithotripsie/endobuccale

Sialendoscopie



La grenouillette

- Forme particulière au niveau de la glande sublinguale
- Obstruction du canal du drainage (Bartholin)
- Tuméfaction molle dépressible
- Soulèvement du plancher buccal antérolatéral sans induration ni trouble de la mobilité linguale.
- TTT: chirurgical par voie endobuccale



III. Sialoses

DEFINITION

- Augmentation de volume chronique isolée de plusieurs glandes salivaires principales, sans douleur ni infection ou signes inflammatoires
- Presque toujours le fait d'une pathologie générale.
- Tuméfaction de l'ensemble de la glande atteinte, indolore de consistance ferme et élastique

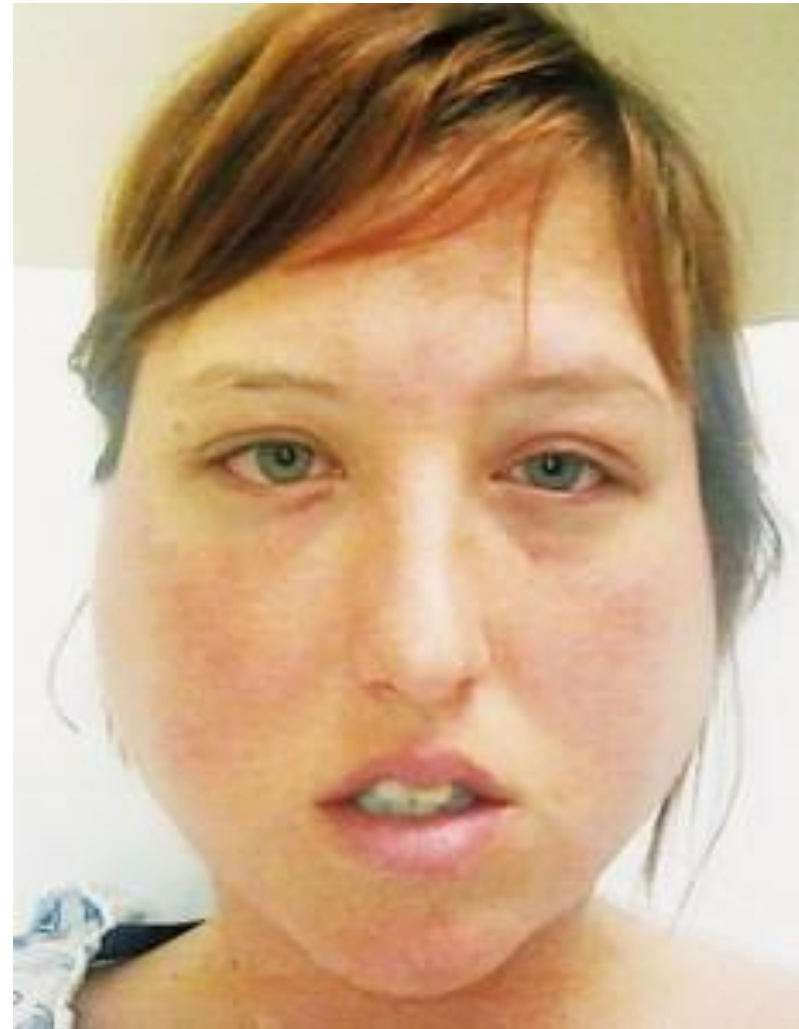
Sarcoidose

- Granulomatose d'origine non encore élucidée, en rapport avec une réponse inflammatoire exagérée
- Atteintes pulmonaires et salivaires (50% des cas)
- Tableau clinique: parotidomégalie bilatérale
- Syndrome de Heerfordt: hypertrophie parotidienne bilatérale, uveite et paralysie faciale

Syndrome de Heerfordt

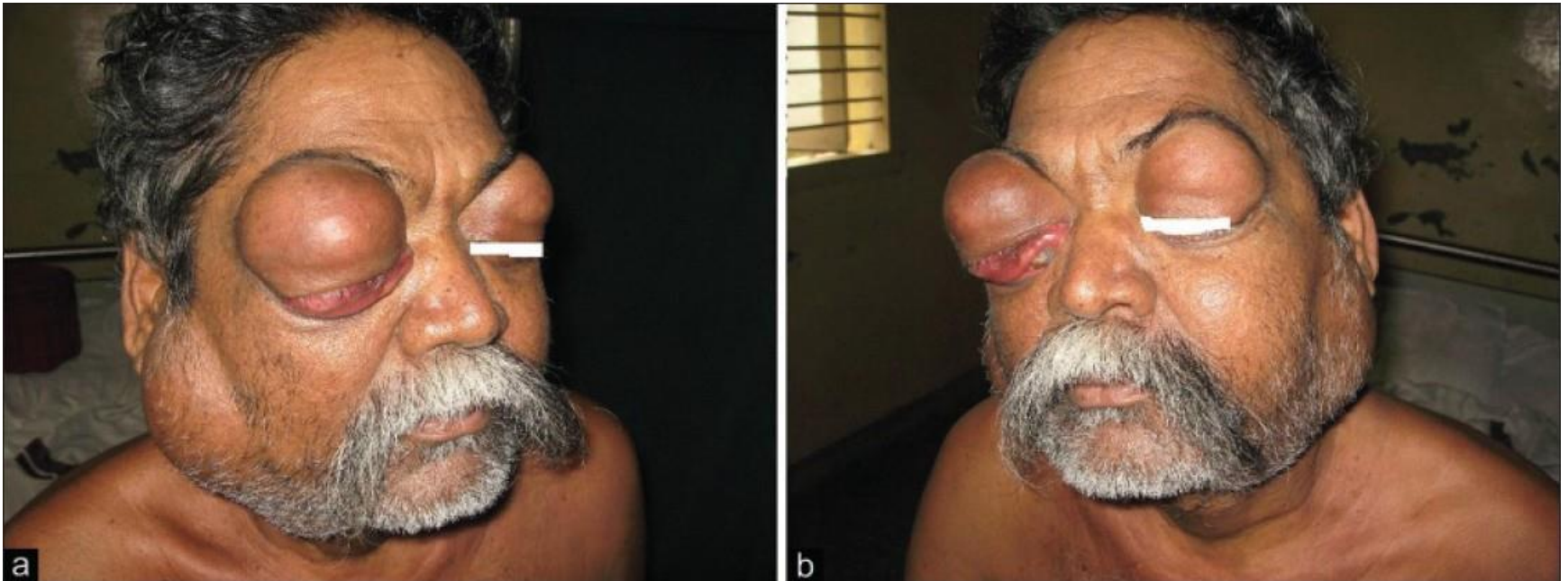
- hypertrophie parotidienne bilatérale, uvéite et paralysie faciale.

**Association syndromique
fréquemment retrouvée dans
La Sarcoidose.**



Syndrome de mikulicz

Atteinte associée des glandes lacrymales bilatérales et hypertrophie parotidienne bilatérale



Diagnostic sarcoidose

- VS +++
- Hypergammaglobulinémie
- HperCa
- IDR –
- ACE +++
- Examen histologique non spécifique : cellules géantes, cellules épithélioïdes , macrophages et lymphocytes T sans caséum.

Syndromes secs

- Gonflement en général parotidien bilatéral diffus, xérophtalmie et xérostomie.
- Goujerot-Sjogren
 - Maladie autoimmune
 - Association: PAR, LED, atteintes digestives, rénales, muculaires, neurologiques...
 - Survient chez la femme entre 40 et 60
 - Dg: biopsie d'une glande salivaire accessoire
 - TTT: immunothérapie, corticothérapie, larmes et salives artificielles, sialagogues (sulfarlem)
- Sialoadénoses
 - S'inscrivent dans le cadre d'atteintes endocrinienne (diabète, hypothyroïdie) métabolique (cirrhose et alcoolisme par carence protéidique), médicamenteuse (Antidépresseurs, antipsychotiques)

Autres sialoses

- Séropositivité VIH: hyperplasie lymphoïde kystique de la parotide bilatérale, indolore régressant après ttt antirétroviral
- Maladie de Kimura:
- Parotidomégalie essentielle
 - ☐ Obésité
 - ☐ Pain
 - ☐ OH

IV. Tumeurs des glandes salivaires

Tumeurs bénignes

❑ Adénome mono (10%) ou pleiomorphe (80%)

- Risque évolutif 10 %
- Risque récidive

❑ Cystadénolymphome = Tumeur de Whartin

Adénome pléomorphe

- 50% des tumeurs parotidiennes
- Histologie: coexistence d'éléments épithéliaux et mésenchymateux
- Clinique:
 - syndrome tumoral lentement progressif sur plusieurs années !!!
 - Tuméfaction unilatérale de la loge parotidienne **indolore**
 - Découverte fortuite
 - Mimique faciale toujours normale
- Examens complémentaires
 - Echographie: confirmer siège intraglandulaire
 - IRM caractéristique
- TTT: chirurgical

Parotidectomie (ou sousmaxillectomie), dissection et conservation du nerf facial et ablation de la tumeur sans effraction capsulaire.

Tumeur de Whartin

- **Ne s'observe que dans la parotide siège au pôle inférieur**
- Ne dégénère jamais
- Homme entre 40 et 60 ans
- Consistance molle et élastique
- Évolution lente
- Dg: parotidectomie exploratrice
- TTT: parotidectomie partielle avec conservation du nerf facial

Tumeurs épithéliales malignes

Tumeurs mucoépidermoïdes

- Environ 45% des toutes les tumeurs malignes des glandes salivaires.
- Evolution bénigne
- Ttt : chirurgical

Tumeurs à cellules acineuses

- 10 % de toutes les tumeurs malignes des glandes salivaires
- Ttt: chirurgical
- Survenue de métastases à distance dans 5% des cas

Adénocarcinomes

- Environ 20% des toutes les tumeurs malignes des glandes salivaires.
- S'observent à tout âge.
- Dégénérescence d'un adénome pléomorphe préexistant
- Souvent douloureuse
- **Paralysie faciale**
- **S'accompagne d'adénopathies cervicales**
- IRM : tumeur aux contours mal définis
hyposignal en T1 et prise de contraste après gadolinium

TTT: chirurgie d'exérèse et évidement ganglionnaire + Radio thérapie

Carcinomes adénoïdes kystiques

- Environ 10% des toutes les tumeurs malignes des glandes salivaires.
- S'observent à tout âge.
- Femme ++
- Tumeur dure, inégale
- Douleurs spontanées à la palpation++++
- **Potentiel de récurrence locale**
- TTT: chirurgie d'exérèse avec conservation du nerf facial + Radio thérapie

- **Clinique:** Vitesse évolution, taille, siège, mobilité, peau, Adénopathies cervicales, extension
- **Cytoponction**, jamais de biopsie (effraction tumorale, risque nerveux) ■
- **Imagerie:** **au mieux IRM**, sinon TDM, échographie; bilan d'extension
- **Traitement:** chirurgie **TOUJOURS !!!**
 - Parotidectomie superficielle avec extemporané +/- totalisation +/- curage JC homolatéral
 - +/- RTE +/- chimio
 - Risques parotidectomie: VII, Frey, creux, dysesthésie lobule, cicatrice, hématome, infection, sialocèle